

מדיניות המרכז הרפואי הדסה נוהל אומדן כאב מספר: 03-05-07-01		המרכז הרפואי האוניברסיטאי הדסה מיסודו של ארגון נשות הדסה
הספר: 03, סיעוד		התחום: 05, הנחיות מקצועיות
הנושא: 07, כאב		הנוהל: 01, אומדן כאב
מהדורה: חמישית		עדכון: מאי 2024
עמוד 1 מתוך 14		עדכון מהדורה רביעית ע"י: רונית מידן אחות ראשית היחידה לשיכוך כאב עין כרם, בונין פולינה מרכזת נושא כאב חריף הר הצופים
העדכון אושר ע"י (לפי א"ב): ד"ר רלי אלון סמנכ"לית סיעוד ומקצועות הבריאות, ד"ר תמר אלרם מנהלת הדסה ה"צ, פרופ' אליעד דוידסון מנהל יחידת כאב, רונית מידן אחות ראשית היחידה לשיכוך כאב עין כרם, פרופ' יניב שרר מנהל הדסה ע"כ.		
גורם מתאם בבית החולים: ציפי עזריה שיפמן מנהלת תחום נהלים וסטנדרטים מקצועיים, המערך לאיכות ובטיחות		
תחומי האקרדיטציה: COP 6, AOP 2, AOP 1.5 (JCI מהדורה 7)		
הנוהל מיועד לנשים ולגברים כאחד		

1. סימוכין

- חוזר מינהל הסיעוד מס' 155/19 מיום 03.11.19 בנושא " [אומדן, מניעה וטיפול בכאב על ידי אחות מוסמכת במערך האשפוז והקהילה](#) ".

2. נספחים

- נספח 1: [כלי אומדן כאב: תרשים זרימה](#).
- נספח 2: [סרגלי כאב למטופלים מתקשרים, ילדים ובוגרים](#).
- נספח 3: [סרגל לתינוקות וילדים לא מתקשרים](#) - Modified FLACC – מגיל 0.
- נספח 4: [סרגל NPASS לפגים](#).
- נספח 5: [סרגל PAINAD לבוגרים דמנטיים / עם קשיי תקשורת](#).
- נספח 6: [סרגל BPS למבוגרים מונשמים](#).
- נספח 7: [אומדן כאב מורחב](#).
- נספח 8: [עדכוני הנוהל](#)

3. מבוא

- כאב הוא סימפטום סובייקטיבי והוא כל מה שהאדם מגדיר ככאב.
- אומדן כאב הוא השלב הראשון בניהול הטיפול בכאב.
- טיפול בכאב מגביר את תחושת הרווחה של הפרט, מאפשר שינה רציפה ומשפר את התפקוד. לכאב לא מטופל השלכות גופניות ונפשיות שליליות. המרכז הרפואי הדסה מכיר בזכות המטופל לטיפול רפואי נטול כאב ככל האפשר.

4. מטרה

- לקבוע דרכי פעולה אחידות לביצוע אומדן כאב, לשם איתור כאב באופן יזום ושיגרתי ולשם הבטחת טיפול נאות בכאב. (COP 6 ME 1)

5. חלות

הנוהל חל על כלל האחים/ות המוסמכים/ות והרופאים, העובדים ביחידות, מחלקות, מרפאות, מכונים וכו' בבתי החולים של הדסה.

6. הגדרות

6.1 **כאב:** "חווייה פיזית ורגשית לא נעימה, הקשורה לנזק רקמתי ממשי או פוטנציאלי". (IASP). "כאב הוא כל מה שהאדם החש אותו ומתנסה בו אומר שהוא". (Margo Mc Caffey)

6.3 **אומדן כאב:** הערכת עוצמת הכאב. במיון ובפסיכיאטריה יכלול גם **מיקום**

6.4 **אומדן כאב מורחב (אדמ"ת):** תשאול המטופל במטרה לאפיין את הכאב ולסייע בהתאמת הטיפול לשיכוך כאב.

רכיבי האומדן המורחב הינם **אדמ"ת:**

אופי - תיאורי תחושתו כגון לוחץ, דוקר, שורף, פועם וכו'.

דרגה - עוצמת הכאב לפי דירוג ע"פ כלי אומדן מותאם לאוכלוסייה

מיקום - מיקום הכאב המרכזי

תדירות הכאב - רמת התכיפות שהכאב מופיע: קיים כל הזמן (מתמשך) ו/או לסירוגין (התקפי/מתפרץ)

אומדן כאב מורחב: יבוצע בעת הקבלה למחלקת האשפוז ובעת הופעת כאב חדש / ממקור חדש

([נספח 7](#))

6.5 **NRS Numeric pain Rating Scale** – דירוג מספרי של עוצמת הכאב בסקאלה של 0-10 (0- ללא כאב,

10 - כאב בלתי נסבל). ניתן גם לתאר טווחי כאב: 1-3 מתאר כאב קל, 4-6 כאב בינוני, 7-10 כאב חזק.

6.6 **VAS visual analogue scale** - דירוג עוצמת הכאב בסקאלה בין 0-100 -בשימוש בעיקר במחקר

6.7 **אומדן כאב חוזר:** תיעוד עוצמת כאב 30-90 דקות ממתן מנת הצלה, למטופלים עם כאב בעוצמה בינונית ומעלה (NRS מעל 5).

7. סמכות ואחריות

7.1 באחריות האחות המוסמכת לזהות ולאתר מטופל החווה כאב ו/או בפוטנציאל לחוות כאב.

7.2 באחריות ובסמכות האחות המוסמכת לבצע אומדן כאב באמצעות כלי אומדן מותאם.

7.3 באחריות האחות המוסמכת לתעד את ממצאי האומדן ולהתערב בכאב בינוני ומעלה לפחות.

7.4 באחריות ובסמכות הרופא מתן הוראה לטיפול תרופתי בכאב.

8. שיטה

8.1. עקרונות בביצוע אומדן כאב

8.1.1. אומדן כאב יש לבצע באופן יזום ושיטתי בהתאם להנחיות הנוהל

8.1.2. אומדן כאב יסייע בהתאמת הטיפול ובהערכת יעילותו

8.1.3. ביצוע אומדן כאב מבוסס על דווח המטופל או על ממצאי אומדן באמצעות כלים מותאמים למטופלים

מתקשרים / או לא מתקשרים ([טבלה 1](#))

8.1.4. בקרב מטופלים לא מתקשרים אשר אינם מסוגלים לדווח על כאבם, כגון: מטופלים דמנטיים, עם פיגור,

במצבים פסיכיאטריים ואחרים, כלי האומדן מתייחסים למדדים פיזיולוגיים והתנהגותיים ומבוססים על

תצפית והערכת האחות.

8.1.5. הסטנדרט המוסדי מתייחס לכלי האומדן הייעודיים (טבלה 1), לעיתוי ביצוע האומדן (טבלה 2) ולהתאמת האומדן למתארים השונים (טבלה 3).

8.2. כלי האומדן

כלי האומדן משמשים למדידת עוצמת כאב ומייצגים טווחי כאב ממצב העדר כאב ועד למצב בו הכאב בלתי נסבל. קיימים כלי אומדן שונים בהתאם למאפייני האוכלוסייה.

טבלה 1: כלים לאומדן כאב על פי אוכלוסיית היעד	
אוכלוסיית היעד	כלי האומדן
ילדים סביב גיל 4-5 ילדים סביב גיל 6-7	סרגל פרצופים סרגל מילולי
ילדים מגיל 8 ומעלה מבוגרים מתקשרים	NRS Numerical Rating Scale
מבוגרים שאינם מתקשרים	PAINAD Pain Assessment in Advanced Dementia
מבוגרים מונשמים	BPS Behavioral Pain Scale
ילודים וילדים עד גיל 7 שנים ו/או ילדים שאינם מתקשרים	FLACC (modified) face, Legs, Activity, Cry, Consolability
פגים	N-PASS Neonatal, Pain, Agitation & Sedation

8.3. עיתוי ביצוע אומדני כאב בקרב מאושפדים

טבלה 2	
הערות	עיתוי ביצוע אומדן כאב
עד 8 שעות מהקבלה למחלקה : יבוצע אומדן מורחב	בקבלה לאשפוז
במשמרת בוקר	אחת ליממה (X1/d)
- למטופלים בטיפול קבוע באופיואידים - למטופלים המדווחים על עוצמת כאב בינוני ומעלה (מעל 5 NRS) - עד 72 שעות לאחר ניתוח	פעם במשמרת (X3/d)
תיעוד עוצמת כאב 30-90 דקות ממתן מנת הצלה למטופלים עם כאב בינוני ומעלה (NRS מעל 5).	אומדן חוזר
- לפני כל פעולה הכרוכה בכאב יש להציע אנלגטיקה מקומית או ססטמית - במידה ובמהלך הפרוצדורה המטופל מדווח על כאב בינוני או חזק, יוסיפו הרופא או האחיות משכך כאב מהיר השפעה - בסיום הפרוצדורה יש לאמוד ולתעד עוצמת כאב	סביב פרוצדורה הכרוכה בכאב
בקרב מטופלים הכאובים במהלך שהותם בבית החולים אשר טופלו במשככי כאב ו/או עברו סדציה, יש לבצע הערכת כאב טרם שחרור / העברה	אומדן כאב בשחרור / העברה

8.4. הליך ביצוע האומדן

8.4.1. בחירת הכלי המתאים למטופל.

8.4.2. הדרכת המטופל תתבצע בקבלת מטופל מתקשר למחלקה. ההדרכה תכלול:



- הסבר על סרגל הכאב (סרגל פנים / מילולי / מספרי);
- חשיבות הדיווח על כאב בינוני ומעלה (מעל 5 בסולם 0-10);
- חשיבות הטיפול בכאב ;

8.4.3. ביצוע אומדן כאב עפ"י הכלי הנבחר והתדירות הנדרשת (לפי טבלאות 1-3).

8.4.4. טיפול בכאב בהתאם להנחיות המחלקתיות ולהוראת רופא .

8.4.5. כאב בינוני ומעלה (NRS מעל 5), ביצוע אומדן חוזר 30-90 דק' ממתן טיפול.

8.5. סטנדרט מינימאלי לביצוע אומדן כאב בהתאמה ליחידות טיפול

טבלה 3							
מחלקות אשפוז	בקבלה	אחת ליממה	פעם במשמרת	כשמטופל מדווח על כאב	אומדן חוזר למטופלים עם כאב בינוני ומעלה (NRS מעל 5)	סביב פעולה פולשנית	בסמוך לשחרור / העברה
+	+	+	+	+	+	+	+
מחלקות אשפוז	אומדן מורחב	+	לפי הגדרה בטבלה 2	+	+	+	לפי הגדרה בטבלה 2
חדרי מיון	עוצמה ומיקום	+		+		+	
אמבולטורי מטופל המתקבל ע"י אחות	+			+		+	
התאוששות	+		אחת לשעה	+	+	+	בסמוך להעברה למחלקה
מלונית יולדות	+			+			
ראה סעיף 8.5.1	יילודים						
ראה סעיף 8.5.2	מחלקת שיקום						
ראה סעיף 8.5.3	פסיכיאטריה והפרעות אכילה						
ראה סעיף 8.5.4	מיון מילדותי וחדר לידה						

8.5.1. יילודים

8.5.1.1. אומדן כאב ליילודים המאושפזים בתינוקיה יבוצע אחת למשמרת רק במצבים הבאים:

- שבר באחת מעצמות השלד, נפיחות וחשד לשבר, לאחר ברית, לידה מכשירנית טראומטית.
- בכל חשד לאי נוחות אצל היילוד לשיקול דעת האחיות המוסמכות.

8.5.1.2. אומדן כאב יבוצע לכל היילודים בכל מקרה לאחר פרוצדורה חודרנית ועד שעה מסיימה (פרוצדורה

חודרנית כולל: (ניקור מותני, דיקור שלפוחית השתן).



8.5.2 מחלקת שיקום

- 8.5.2.1 **אומדן כאב מורחב** יבוצע לכל מטופל בקבלה למחלקה, בעת ביצוע קבלה סיעודית ועד 8 שעות מהקבלה.
- 8.5.2.2 לכל המטופלים יבוצע **אומדן כאב אחת ליממה** מיום קבלתם למחלקה. במידה ואומדן הכאב הינו בציון 0/10 במשך 6 מדידות יומיות רצופות, ניתן להפסיק ביצוע אומדן כאב אחת ליממה.
- 8.5.2.3 **אומדן כאב יבוצע/יחודש במצבים הבאים אחת למשמרת:**
- ✓ בעת תלונות המטופל על כאב (לאחר 3 מדידות רצופות ללא כאב ניתן להפסיק ביצוע אומדן כאב)
 - ✓ לאחר התחלת טיפול תרופתי חדש לשיכוך כאב עד לאיזון כאב (לאחר 3 מדידות רצופות ללא כאב ניתן להפסיק ביצוע אומדן כאב)
 - ✓ מטופלים לאחר ניתוח/ טראומה חריפה / פרצדורה פולשנית במשך 72 שעות לאחר ביצוע הפעולה.
 - ✓ בכל מצב אחר לשיקול דעת האחיות המוסמכות .

8.5.3 פסיכיאטריה והפרעות אכילה

- 8.5.3.1 אומדן כאב יבוצע לכל המטופלים בקבלה למחלקה, עד 8 שעות מהקבלה
- 8.5.3.2 אומדן כאב יומי (עוצמה ומיקום) יבוצע במקרים הבאים:
- ✓ מטופלים פסיכיאטרים הסובלים מבעיות גופניות.
 - ✓ מטופלים פסיכיאטריים הנוטלים משככי כאב באופן קבוע.
 - ✓ מטופלים פסיכיאטרים המתלוננים על עוצמת כאב בינונית ומעלה (NRS מעל 5).
 - ✓ מטופלים לאחר ניתוח במשך 72 שעות לפחות
 - ✓ מטופלים ביממה הראשונה לאחר פרצדורה פולשנית / הכרוכה בכאב (לדוגמא ECT).
 - ✓ בכל מצב אחר לשיקול דעת האחיות המוסמכות.

8.5.4 מיון מילדותי וחדר לידה

8.5.4.1 במיון מיילדותי:

- ✓ בעת קבלת היולדת ,
- ✓ בעת דיווח על כאב בינוני או חזק (מעל 5/10),
- ✓ בעת בקשת משכך כאב,
- ✓ 30-60 דק' ממתן טיפול לכאב,
- ✓ כל 4 שעות לפחות.
- ✓ נשים המגיעות להערכה מילדותית ולא נמצאות בלידה: אומדן כאב ייעשה בקבלה ובהמשך על-פי הצורך.

8.5.4.2 בחדר לידה: בעת קבלת היולדת

8.5.4.2.1 יולדת בלידה טבעית (ללא משככי כאב):

- ✓ בעת בקשת משכך כאב,
- ✓ 30-60 דק לאחר מתן טיפול,
- ✓ כל שעתיים לפחות,
- ✓ בעת הערכת היולדת לאחר הלידה.

עמוד 6 מתוך 14	נוהל אומדן כאב	03-05-07-01	
----------------	----------------	-------------	---

8.5.4.2.2 יולדת המטופלת במשככי כאב Epidural / IV:

- ✓ בעת הכנסת אפידורל
- ✓ 15-30 דק' אחרי toppup אפידוראלי
- ✓ כל שעתיים לפחות
- ✓ בעת הערכת היולדת לאחר הלידה

9. דווח ותיעוד

יש לתעד את תוצאת אומדן הכאב, את ההתערבות ואת יעילותה ברשומה הסיעודית. כל כאב בינוני ומעלה (NRS מעל 5) מחייב התייחסות (תיעוד מתן תרופה, התערבות לא תרופתית, או תיעוד סיבת אי מתן טיפול). אומדן כאב יש לתעד "בדף מדדים והתערבויות".

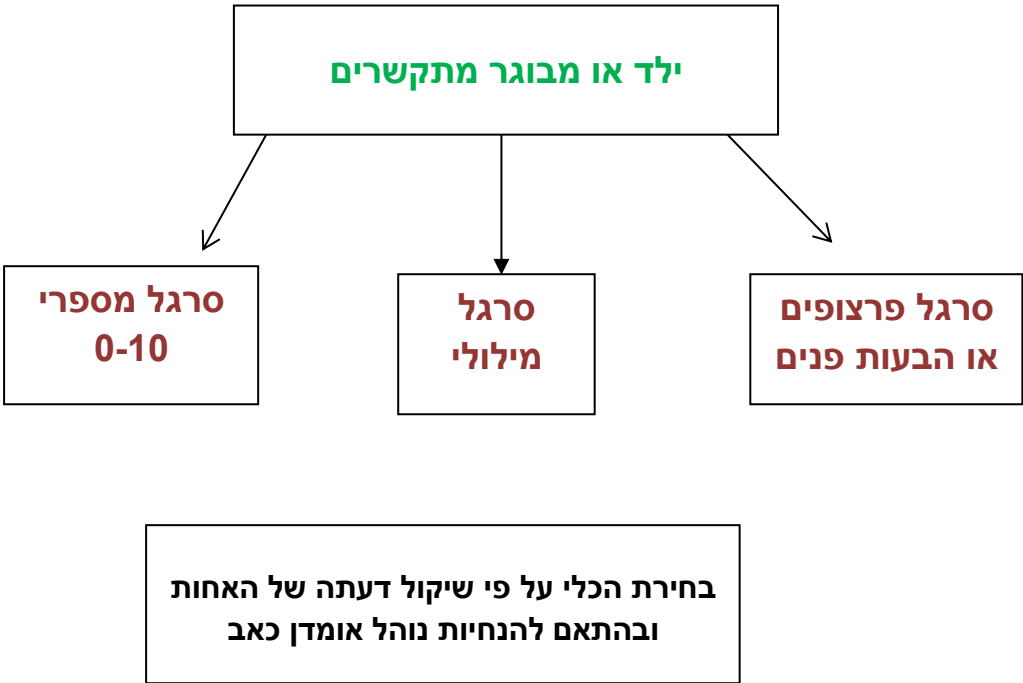
10. הטמעה והכשרה

- 10.1. הנוהל יופץ לעובדים באופן ישיר למייל האישי שלהם בהדסה ועל-ידי המנהלים הישירים.
- 10.2. העובדים ידרשו לחתום על קריאת הנוהל במערכת Teach.
- 10.3. הדרכה בנוגע לנוהל זה תינתן בעת קבלת עובד חדש למחלקה.
- 10.4. באחריותם של מנהלי המחלקות והאחיות הראשיות להטמיע נוהל זה בקרב העובדים שלהם.

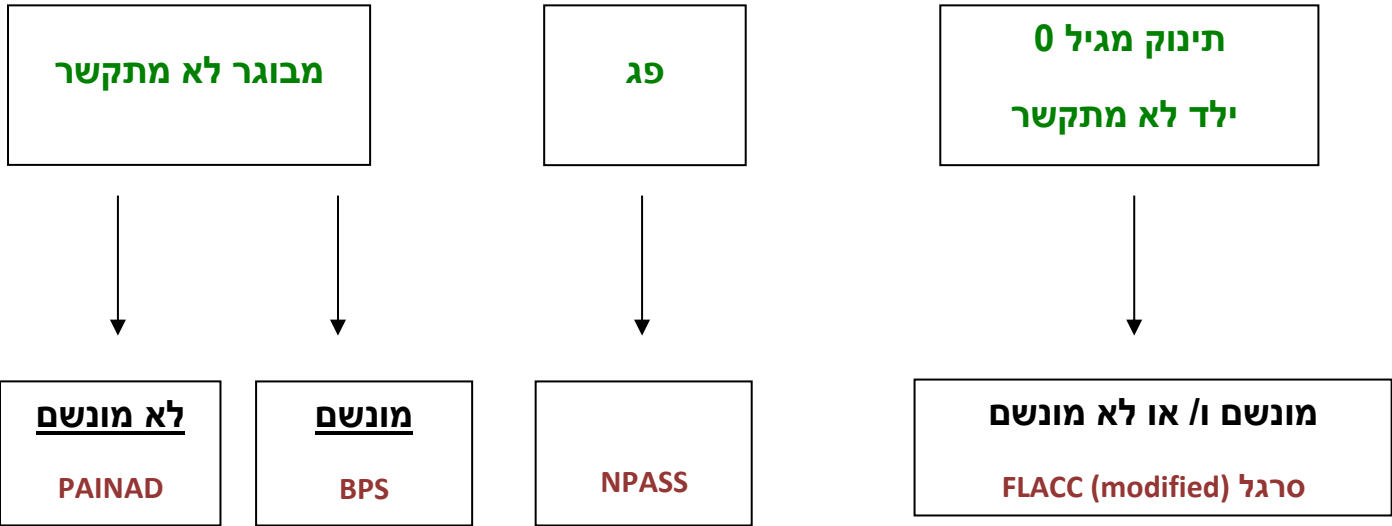


נספח 1: כלי אומדן כאב: תרשים זרימה

- כלי אומדן כאב למטופלים מתקשרים



- כלי אומדן כאב למטופלים לא מתקשרים



נספח 2: סרגלי כאב למטופלים מתקשרים, ילדים ומבוגרים (ציון 0-10)

סרגל מספרי, מילולי והבעות פנים

סרגל מספרי מילולי ופנים



התאמת הכלי לילד ייעשה על פי שיקולה דעתה של האחות

סרגל הבעות פנים / פרצופים: מתאים לילדים מתקשרים סביב גיל 4-5 שנים

סרגל מילולי: מתאים לרוב הילדים מתקשרים סביב גיל 6-7 שנים

סרגל מספרי: 0-10 מתאים לרוב הילדים מתקשרים סביב גיל 8 ומעלה

נספח 3: סרגל לתינוקות וילדים לא מתקשרים - Modified FLACC – מגיל 0 (ציון 0-10)

(Face , Legs , Activity , Cry, Consolability)

ניקוד	2	1	0	
	סנטר רוטט לעיתים קרובות או באופן קבוע / לסתות נעולות	מעוות או מקמט פנים מידי פעם, מכונס בעצמו או אדיש	ללא הבעת פנים מיוחדת או חיוך	הבעת פנים
	בועט או רגלים מכופפות	חסרות מנוחה, באי שקט, מתוחות	תנוחה רגילה או נינוחה	רגלים
	בתנוחת קשת, נוקשה או נע בתנועות עוויתיות	מתפתל, תנועות הלוך ושוב, מתוח	שכיבה רגועה, תנוחה רגילה זז בקלות	פעילות
	בוכה באופן קבוע , צווח או מתייפח, מתלונן לעיתים תכופות. לחולה מונשם: הבעות פנים של בכי / צווחות	נאנח / מייבב, מתלונן מידי פעם לחולה מונשם: הבעות פנים של בכי, מידי פעם	ללא בכי (ער או ישן) לחולה מונשם: הבעת פנים רגועה, ללא בכי	בכי
	קשה לנחם או להרגיע	נרגע מידי פעם בתגובה למגע או חיבוק או שיחה. ניתן להסיח את דעתו	רגוע , שבע רצון	יכולת להירגע
0-10	ציון סופי			

הנחיות לצוות המטפל: יש לתת ציון לכל אחד מחמשת הסעיפים. הציון הסופי נע בין 0-10 .

כאב מעל 3 מחייב התייחסות

0 : ללא כאב או אי נוחות **1-3 :** כאב / אי נוחות ברמה קלה

4-6 : כאב / אי נוחות ברמה בינונית **7-10 :** כאב / אי נוחות ברמה קשה

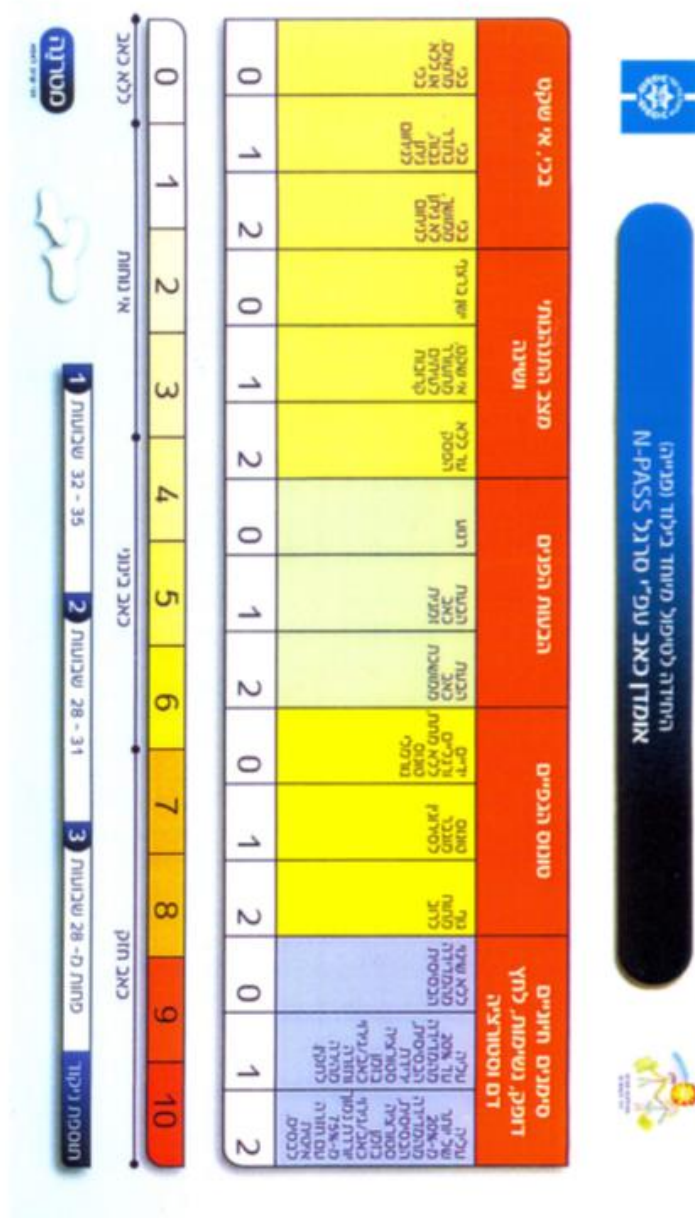
מקור: זסלנסקי ושות'. 2006. סולם התנהגותי למדידת כאב בגיל הילדות במצבים שאינם מאפשרים דיווח עצמי . הרפואה, כרך 145, חוב' ט', עמ' 648-651.

Monica Johansson and Eva Kokinsky, 2009. The COMFORT behavioural scale and the modified FLACC scale in paediatric intensive care. British Association of Critical Care Nurses, Nursing in Critical Care ,Vol 14 ,3, pp122-130

נספח 4: סרגל NPASS לפגים (ציון 0-10)

Neonatal Pain Agitation and Sedation Scale

NPASS לפגים



מקור:

Clinical reliability and validity of the N-PASS: .P Hummel, M Puchalski, S D Creech and M G Weis
Journal of Perinatology (2008) 28, .neonatal pain, agitation and sedation scale with prolonged pain
55–60.

נספח 5: סרגל PAINAD לבוגרים דמנטיים / עם קשיי תקשורת (ציון 0-10)

Pain Assessment in Advanced Dementia Scale

ניקוד	2	1	0	
	נשימות כבדות וקולניות. נשימות מהירות לאורך זמן. נשימות Cheyne- Stokes	נשימה מאומצת או מהירה לעיתים	נשימה רגילה	נשימה
	בכי / צעקות כל הזמן / אנחות בקול רם	נאנח / גונח מעת לעת דיבור רפה	לא משמיע קולות	קולות
	כיווץ חזק של שרירי הפנים	עצוב / מראה פנים מפוחד / קימוט מצח ו/או סביב הפה	חיוך או העדר הבעה	הבעות פנים מימיקה
	נוקשות, אגרופים קמוצים / תנוחה עוברית / מושך או דוחף בזמן טיפול / התנגדות חזקה למטפל	גוף מתוח הליכה בחוסר מנוחה/ תנועות עצבניות / תנועות מונוטוניות	גוף רגוע	שפת גוף
	לא ניתן להרגעה / לא ניתן להסיח את דעתו	נרגע או דעתו מוסחת על ידי קול או מגע של המטפל	אין צורך בהרגעה רגוע / מרוצה	יכולת הירגעות
0-10	ציון סופי			

הנחיות לצוות המטפל: יש לתת ציון לכל אחד מחמשת הסעיפים. הציון הסופי נע בין 0-10.

כאב מעל 3 מחייב התייחסות

0 : ללא כאב או אי נוחות 1-3 : כאב / אי נוחות ברמה קלה

4-6 : כאב / אי נוחות ברמה בינונית 7-10 : כאב / אי נוחות ברמה קשה

מקור:

Warden V1, Hurley AC, Volicer L. Development and psychometric evaluation of the Pain Assessment in Advanced Dementia (PAINAD) scale. *J Am Med Dir Assoc.* 2003 Jan-Feb; 4(1): 9-15.



נספח 6: סרגל BPS למבוגרים מונשמים (ציון 3-12)

Behavioral Pain Scale		
מרכיב	מאפיין	ציון
הבעת פנים	נינוח	1
	כיווץ חלקי של הפנים (גבות)	2
	כיווץ מלא של הפנים (סוגר עיניים)	3
	מעוות פנים	4
תנועת גפיים עליונות בתגובה לכאב	ללא תנועה	1
	כיפוף חלקי	2
	כיפוף מלא עם פלקציה של האצבעות	3
	כיווץ רציף של הגפיים	4
היענות למכונת הנשמה	היענות מוחלטת	1
	משתעל אך סובל את המכונה	2
	נלחם בהנשמה	3
	חוסר תיאום מוחלט בין המטופל להנשמה	4

הנחיות לצוות המטפל:

יש לתת ציון לכל אחד מחמשת הסעיפים. הציון הסופי נע בין 3-12. כאב / אי נוחות מעל 6 מחייבים התייחסות

3 : ללא כאב או אי נוחות

4-6 : כאב / אי נוחות ברמה קלה

7-9 : כאב / אי נוחות ברמה בינונית

10-12 : כאב / אי נוחות ברמה קשה

מקור :

Aïssaoui Y, Zeggwagh AA, Zekraoui A, Abidi K, Abouqal R. Validation of a behavioral pain scale in critically ill, sedated, and mechanically ventilated patients. *Anesth. Analg.* 2005 Nov.;101(5):1470-6.



נספח 7: אומדן מורחב מעודכן לפי "אדמת"

מופע חדש ללא שם		1/1
15/02/2024 07:54		תאריך
☐ לוחץ	☐	א אופי הכאב
☐ דוקר	☐	
☐ שורף	☐	
☐ פועם	☐	
☐ אחר	☐	
☐	בחר...	ב דרגת הכאב (0-10)
☐ איבר בגוף	☐	ג מיקום הכאב המרכזי
☐ אזור הניתוח או הפרוצדורה	☐	
☐ אחר	☐	
☐ מתמשך (קיים כל הזמן)	☐	ד תדירות/ תכיפות הכאב
☐ לסירוגין (התקפי / מתפרץ)	☐	
☐ אחר	☐	



נספח 8: עדכוני הנוהל

מהדורת הנוהל	תאריך פרסום	עדכוני הנוהל
רביעית	ינואר 2019	עדכון סעיף 9.1.6 למטופל ישן לא ירשם כאב, אלא יתועד ישן/ S. מצב זה מחייב לחזור ולבצע אומדן כאב בזמן ערות.
		עדכון סעיף 9.3.1 מלר"ד בעוצמת כאב 5 ומעלה, יבוצע אומדן חוזר בהקדם האפשרי, ובהתאם להערכת זמן השפעת התרופה, רצוי תוך שעה ולא יאוחר משעה וחצי ממתן הטיפול
		עדכון סעיף 9.3.2 בשירות האמבולטורי בעוצמת כאב 5 ומעלה, יבוצע אומדן חוזר בהקדם האפשרי, ובהתאם להערכת זמן השפעת התרופה, רצוי תוך שעה ולא יאוחר משעה וחצי ממתן הטיפול
		עדכון סעיף 9.3.3 במחלקות אשפוז בעוצמת כאב 5 ומעלה, יבוצע אומדן חוזר בהקדם האפשרי, ובהתאם להערכת זמן השפעת התרופה; רצוי תוך שעה ולא יאוחר משעה וחצי ממתן הטיפול
		עדכון סעיף 10 דווח ותיעוד יש לתעד את תוצאת אומדן הכאב, את ההתערבות ואת יעילותה ברשומה הסיעודית. כל אומדן כאב מעל 3 מחייב התייחסות, באומדן 5 ומעלה יש לבצע אומדן חוזר ולתעד ברשומת המדדים הסיעודית. ברשומה ממוחשבת יש לתעד "בדף מדדים והתערבויות". רישום בדיווח הסיעודי אינו פוטר מדיווח ברשומת המדדים. לחולה שסירב לקבל משככי כאב למרות מתן ההסבר יש לציין זאת.
חמישית	מאי 2024	שינוי נרחב

היסטורית כתיבה ואישור הנוהל

מהדורה	תאריך פרסום	כותבי ומעדכני הנוהל	אישורי הנוהל
מהדורה ראשונה - שניה	לא ידוע		
שלישית	אפריל 2016		
מהדורה רביעית	ינואר 2019	רונית מידן אחות ראשית, היחידה לשיכוך כאב עין כרם, ראשית בייזר מרכזת נושא כאב חריף הר הצופים	פרופ' אליעד דוידסון מנהל יחידת כאב, רונית מידן אחות ראשית היחידה לשיכוך כאב עין כרם, ראשית בייזר מרכזת נושא כאב חריף הר הצופים